

Eosinofilia

Bibliográfica Hospital Perrupato – Dr. Navarro David – 2019
PONAP 2004

Proporción normal de eosinófilos:

- RN: 5 al 8%
- Lactantes y niños: 1 a 4% (100-200mm³)

Función:

Símil neutrófilos son móviles fagocitarios en menor medida que los neutrófilos y su efectividad es reducida para la destrucción de microorganismos.

Actúan principalmente contra parásitos y tb sobre células y tejidos normales (esto explica las lesiones viscerales múltiples y graves del síndrome hipereosinofílico idiopático).

Ubicación:

Preferentemente en la capa submucosa de los tractos respiratorio, gastrointestinal y génitourinario.

Clasificación:

- **Leve:** > 400/mm³ - < 1.000/mm³
- **Moderada:** 1.000 - 2.000/mm³
- **Grave o hipereosinofilia:** > 2.000/mm³

- Vida media del eosinófilo: 4 a 12 horas en sangre y 20 horas en tejidos
- La presencia de eosinofilia supone una estimulación medular constante.
- Bazo: depósito regulador.

Etiología:

1. **Infeccioso (+ frecuente)**
2. **Autoinmune (alérgico o por hipersensibilidad)**
3. **Enfermedades del tejido conectivo**
4. **Neoplásico**

Perfiles patogénicos:

Perfil	Compromiso orgánico
Perfil de infección parasitaria	Antecedente epidemiológico + síntomas y signos digestivos + curso agudo o subagudo
Perfil autoinmune	Signos de vasculitis + poliartritis + hematuria + hipertensión + evolución subaguda o crónica
Perfil neoplásico	Datos de compromiso general + adenopatías + hepatomegalia + datos de localización univisceral o multivisceral.

1. Eosinofilia infecciosa

Características generales:

- Es más frecuente en las infecciones por helmintos que por protozoos.
- Los helmintos que invaden los tejidos producen mayor eosinofilia que los que permanecen en la luz intestinal.
- La localización en el intestino delgado provoca mayor eosinofilia que las ubicadas en el intestino grueso.
- La eosinofilia es máxima en la fase aguda, cuando se produce la migración y el desarrollo de las larvas.
- Los huevos y las larvas habitualmente no están en las heces en el momento de la máxima eosinofilia.

A. **Toxocara:**

- Parasitosis más comunes como causa de eosinofilia
- **Especie:** ***Toxocara canis*** (parásito del perro) y el ***Toxocara cati*** (del gato)
- Hombre huésped intermediario
- Transmisión:
 - Ingestión de huevos (alimentos, manos contaminadas, fómites)
 - Las larvas, liberadas en el intestino, atraviesan la mucosa y por vía porta alcanzan la circulación general; desde allí alcanzan distintos órganos –principalmente el hígado y el pulmón– donde dan lugar a una reacción inflamatoria con formación de granulomas.
- Más común en niños de 1 a 4 años
- síntomas iniciales:
 - Fiebre,
 - Tos seca
 - Decaimiento
 - Pérdida de peso
 - Puede observarse exantemas pruriginosos y ocasionalmente, nódulos dolorosos
 - Compromiso pulmonar: tipo neumonítico (infiltrados intersticiales), aunque también es posible la afección bronquial o bronquiolar.
 - Granulomas en sistema nervioso y el miocardio: en los casos graves y con respuesta inflamatoria exagerada
 - Compromiso ocular: es posible en las formas generalizadas
- **Laboratorio:**
 - Leucocitosis con eosinofilia de 50 a 90%, que pueden persistir meses o años
 - eritrosedimentación acelerada
 - gammaglobulinas elevadas, en especial IgG e IgE
- **Tratamiento:**
 - Tiabendazol
 - No siempre es efectivo, pero la enfermedad tiende a autolimitarse a través de los meses

B. **Fasciola hepática:**

- También es frecuente
- Eosinofilia más altas en la fase aguda o invasiva y estadios tempranos de la fase crónica, llegando a cifras de 70 a 80%
- **Clínica:**
 - Ictericia
 - Hepatomegalia
 - Dolor en el hipocondrio derecho
 - Dispepsia
- **Examen fresco de materia fecal:** En general hay ausencia de huevos
- **Tratamiento:**
 - Empírico cuando hay clínica y epidemiología: emetina
 - La respuesta clínica positiva es rápida y tiene valor diagnóstico

C. **Triquinosis**

- **Clínica:**
 - Signos de compromiso muscular
 - edema facial
 - Fiebre
 - Indagar a familiares y allegados para detectar casos similares

- **Tratamiento**

- Corticoides y tiabendazol
- Obtiene la remisión de los síntomas, pero esto no significa curación; la recuperación es muy lenta

D. Ancylostoma duodenalis:

- Eosinofilia moderada o alta + presentan anemia ferropriva llamativa, con leucocitos normales o levemente aumentados.
- El hallazgo de huevos en heces proporciona el diagnóstico etiológico

E. Equinococos, Cisticercosis (Cestodes) y ascariasis:

- eosinofilia moderada

F. Otros diagnóstico menos frecuentes:

- La esquistosomiasis: eosinofilia de hasta el 70%.
- La estrongiloidosis: en personas inmunocomprometidas
- Malaria, toxoplasmosis, amebiasis y la tripanosomiasis: eosinofilia leve.
- Micosis: coccidioidomicosis y aspergilosis broncopulmonar: eosinofilia leve
- Escarlatina, sarampión, foliculitis: se puede hallar eosinofilia moderada-grave
- Varicela, parotiditis, herpes Zoster y en infecciones crónicas como meningitis tuberculosa y lepra: se puede hallar eosinofilia moderada

2. Eosinofilia alérgica o por hipersensibilidad:

A. Intolerancia a la leche materna o a la leche de vaca:

- Eosinofilia discreta
- clínica:
 - Diarrea
 - Vómitos
 - Dolor abdominal
 - Sintomatología respiratoria y de piel

Colitis alérgica eosinofílica:

- Presentación especial de alergia a proteínas de la leche
- Clínica:
 - Rectorragia (con o sin diarrea y/o dolor cólico abdominal)
 - Buen estado general
 - Aparición rápidamente después de la ingestión y cede al eliminar éste
- Endoscopia:
 - Lesiones en parcelares
 - Pueden comprometer todo el colon, pero el rectosigmoide es el más frecuentemente

B. Hiperinmunoglobulina E (hiper Ig E):

- Eosinofilia moderada-grave
- Inmunodeficiencia congénita autosómica dominante con penetrancia incompleta
- caracteriza por:
 - Dermatitis crónica grave
 - Infecciones frecuentes
 - Formación de abscesos
 - Ig E elevada (> 2.000 UI/ml)

3. Eosinofilia por tumores

“Considerar ante toda eosinofilia febril de curso subagudo o crónico, aún ante el hallazgo simultáneo de parásitos en los estudios solicitados”

Enfermedad de Hodgkin:

- Eosinofilia moderada en aproximadamente el 20% de los casos
- fiebre prolongada.
- Leucemia Mieloide
- Eosinofilia moderada
- **Signo de mal pronóstico** : eosinofilia persistente, porque indicaría metástasis, especialmente hepáticas

4. enfermedades del tejido conectivo:

A. Poliarteritis Nodosa:

- Sospecharse ante:
 - Fiebre
 - Signos de vasculitis
 - Hipertensión
 - Compromiso renal
- La biopsia de piel y músculo resulta confirmatoria

B. Dermatomiositis

C. Fascitis eosinofílica:

- Edema y dolor en antebrazos y piernas
- Alteraciones dermatológicas (aspecto de piel de naranja)
- Fiebre
- Poliartralgias.
- Eritrosedimentación acelerada
- Hipergammaglobulinemia
- Se confirma el diagnóstico con biopsia de piel y músculo.

5. Síndrome hipereosinofílico (SHE)

A. Secundario

B. Primario o Idiopático, criterios:

1. Eosinofilia superior a 2.000/mm³ durante más de 6 meses.
2. Exclusión de causas obvias de eosinofilia: enfermedades parasitarias, alérgicas y otras menos frecuentes.
3. Presencia de signos o síntomas de daño orgánico por la eosinofilia

Clinica:

- Enfermedad sistémica
- Compromiso cardíaco muy importante(miocarditis) y respiratorio (*proteínas catiónicas* depositadas en los tejidos)
- Lesiones cutáneomucosas
- Manifestaciones oculares
- Esplenomegalia
- Adenopatías
- Fiebre (puede ser importante)
- Leucocitosis, alcanzar a veces cifras leucemoides
- Eosinófilos hasta el 70% y a veces anormales o inmaduros
- Eritrosedimentación acelerada
- De evolución fulminante

Tratamiento:

- Corticosteroides/Interferón
- Agentes alquilantes
- En algunos casos: cirugía cardíaca